PETJOURNEY

Roteiro de Apresentação

Módulo Clínico · demonstração de 12 minutos

Para quem vai apresentar a uma clínica veterinária

Setembro de 2026

Como usar este roteiro

Este documento é para ser lido **antes** e mantido ao lado durante a apresentação. Ele cobre o fluxo clínico inteiro em sete atos, com tempo sugerido para cada um.

Três convenções ao longo do texto:

- **Passos numerados** são o que fazer na tela, na ordem.
- **Blocos em verde** são fala sugerida. Não precisa decorar — a ideia é o argumento, não a frase.
- **Blocos em âmbar** são avisos: coisas que atrapalham a demonstração se ninguém prestar atenção.

No fim há três seções que valem tanto quanto o roteiro: as **perguntas que o cliente costuma fazer**, a lista honesta do **que é real e o que é demonstração**, e o **plano B** para quando algo não responde.

> **O produto está em fase de protótipo navegável.** As telas são reais e funcionam, mas rodam sobre dados de demonstração — não há integração com servidor ainda. A seção "O que é real e o que é demonstração" explica exatamente onde está a linha. Vale lê-la antes de prometer prazo.

Antes de entrar na sala

Cinco minutos de preparação evitam os dois jeitos mais comuns de a demonstração começar mal: o menu não aparecer, ou as telas abrirem vazias.

1. Ligar o módulo clínico

O módulo nasce **oculto** de propósito — ele não aparece para quem entra no portal normalmente. Para ligar, há dois caminhos:

- Acrescentar **?clinico=on** ao fim do endereço de qualquer tela do portal e dar Enter.
- Ou simplesmente **digitar a palavra "clinico"** com o portal aberto, fora de qualquer campo de texto.

O portal guarda essa escolha no navegador: uma vez ligado, continua ligado naquele computador.

> Confirme que os grupos **"Clínico"** e **"Pets"** apareceram no menu lateral **antes** de a plateia entrar na sala. Se não apareceram, o módulo não está ligado — e nenhuma tela deste roteiro existe.

2. Não apresentar num domingo

A clínica de demonstração está **fechada aos domingos**. Num domingo, "Hoje na clínica" e a Agenda abrem vazias, e a apresentação perde os dois primeiros atos.

Se a reunião cair num domingo, avise a equipe técnica com antecedência: é um ajuste de dado, rápido, mas precisa ser feito antes.

3. Ajustar a largura para o projetor

A agenda mostra **cinco colunas de profissional**. Em projetor 4:3 elas apertam e o texto fica pequeno. Use o painel de exibição da própria agenda para deixar **dois ou três** profissionais visíveis antes de começar.

4. Deixar as abas abertas

Abrir tela por tela na frente do cliente custa tempo morto. Deixe estas quatro já carregadas em abas separadas:

- Hoje na clínica
- Agenda

- Um atendimento já aberto (o prontuário do paciente em atendimento)
- Vacinas

Checklist final

Item	Confere
Módulo ligado, “Clínico” e “Pets” no menu	☐
Não é domingo (ou o ajuste já foi feito)	☐
Agenda filtrada em 2–3 profissionais	☐
Quatro abas abertas e carregadas	☐
Som do computador mudo (avisos do sistema)	☐
Zoom do navegador em 100 % ou 110 %	☐

O roteiro — 12 minutos

A ordem importa: cada ato prepara o seguinte. A história é um dia de trabalho da clínica, do momento em que a recepção abre a porta até o documento que o responsável leva para casa.

Ato 0 · A promessa

`antes de clicar em qualquer coisa` **30 s**

Não abra nenhuma tela ainda. Diga de que se trata, em duas frases, olhando para a pessoa e não para o projetor.

> *"Hoje a clínica de vocês vive em três lugares: a agenda num sistema, o prontuário no papel ou no Word, e o contato com o responsável no WhatsApp. O que eu vou mostrar em dez minutos é esse dia inteiro num lugar só — e, no fim, uma parte dele chegando sozinha no celular de quem trouxe o animal."*

Por que isso vende: A plateia precisa saber o que está prestes a ver. Sem essa frase, os primeiros dois minutos são gastos adivinhando.

Ato 1 · Hoje na clínica

`/veterinario/meu-dia` **1 min**

1. Abra **Hoje na clínica**. É a primeira tela do dia.
2. Aponte os três blocos: quem **já está esperando**, quem está **em atendimento**, e o que **vem a seguir**.
3. Não entre em nada ainda. Deixe a pessoa ler a tela por alguns segundos.

> *"Antes de abrir qualquer prontuário, a clínica já sabe onde ela está. Quem chegou, quem está lá dentro, e o que vem depois. É a tela que a recepção deixa aberta o dia todo."*

Por que isso vende: É a primeira impressão de organização. Clínica que trabalha com papel reconhece na hora o que essa tela substitui.

Ato 2 · A agenda

`/veterinario/agenda` **2 min 30 s**

É o coração da demonstração e onde a clínica decide se troca de sistema. Vá devagar aqui.

4. **Mostre a legenda** e clique num tipo de atendimento: a grade filtra na hora. Diga que a cor **nunca vem sozinha** — sempre tem ícone e nome junto, para quem não distingue cores.
5. **Arraste um atendimento** para outro horário. Aparece uma confirmação com o de → para, os avisos, e **o texto que sairia para o responsável**.
6. **Não confirme.** Cancele de propósito, e diga por quê.
7. **Alterne para "por sala"** e volte para "por profissional". Mesmo horário, outro eixo de leitura.

> *"Repare que arrastar não salvou nada sozinho. Toda mudança de horário passa por uma confirmação que mostra o que muda e o que o responsável vai receber. Agenda é a coisa mais fácil de estragar sem perceber."*

Por que isso vende: O medo número um de quem troca de sistema é perder ou bagunçar horário. Mostrar o cancelamento é mais convincente que mostrar o salvamento.

Ato 3 · A falta que vira ligação

`/veterinario/agenda` e `/veterinario/fila` **1 min 30 s**

8. Na agenda, **marque uma falta** pelo botão do próprio card do atendimento.

9. Aponte as três coisas que acontecem juntas: o status muda, a **fila de espera é consultada**, e o **reagendamento abre na hora** — já com horários buscados e o telefone clicável.
10. Abra **Fila de espera**. Mostre a posição de cada um e a **oferta de vaga com prazo**.

> *"Falta é dinheiro perdido, e normalmente ninguém tem tempo de correr atrás. Aqui a falta já abre a ligação, com o horário novo sugerido e o telefone na tela. Vira uma ligação de trinta segundos, não uma linha num relatório que ninguém lê."*

Por que isso vende: É o primeiro número concreto da conversa. Pergunte quantas faltas eles têm por semana — a conta se faz sozinha na cabeça deles.

Ato 4 · O atendimento

`prontuário do paciente em atendimento` **4 min**

O trecho mais longo, e o que justifica o produto. São cinco etapas: anamnese, exame físico, diagnóstico, conduta e resumo.

4.1 · O cabeçalho do paciente

11. Aponte que **alergia e comorbidade aparecem sem clicar em nada**.

> *"Isso não está escondido numa aba. Quem abre o prontuário vê o que não pode esquecer antes de ler qualquer outra coisa."*

4.2 · Exame físico — o momento do peso

12. **Afira o peso** do animal no campo de peso.
13. Mostre que **a dose recalcula sozinha** e o cabeçalho acompanha, marcando "hoje".
14. Registre um sinal vital **fora da faixa**. Aparece seta, palavra e a faixa de referência da espécie, porte e idade.

> *"O peso de hoje não é o peso do cadastro. No momento em que o animal sobe na balança, tudo que depende de peso se ajusta — inclusive a dose que vai sair na receita. É o erro mais comum de receita manual, e aqui ele não tem como acontecer."*

Por que isso vende: É a demonstração mais técnica e a que mais impressiona veterinário. Faça devagar e deixe a pessoa ver o número mudar.

4.3 · Digitação rápida

15. Clique em **"Ver teclas"** ao lado das etapas.
16. Mostre: **Enter** avança de campo, **Alt + setas** mudam de etapa, e **números escolhem** direto a opção de um grupo.

> *"A consulta inteira sem tirar a mão do teclado. Quem digita enquanto atende sabe o quanto isso muda — o mouse é o que faz o veterinário olhar para a tela em vez de olhar para o animal."*

4.4 · Diagnóstico e conduta

17. No **diagnóstico**, busque no catálogo e marque um diferencial.
18. Na **conduta**, prescreva pelo bulário. Mostre **a conta aberta**: peso × mg/kg = dose.
19. Mostre o **fracionamento em palavra** — "meio comprimido", não "0,5".
20. Prescreva algo a que o paciente tem **alergia registrada**. O alerta exige confirmação explícita, mas **não impede**.

> *"A conta aparece porque o veterinário confere de cabeça. Número pronto num campo ninguém confere. E o alerta de alergia não bloqueia: quem decide é o profissional, o sistema só garante que ele viu."*

Por que isso vende: Respeitar a autonomia do veterinário é argumento de venda. Sistema que bloqueia é sistema que o profissional aprende a burlar.

Ato 5 · A receita

`mesma tela, painel de receita` **1 min 30 s**

21. **Assine e emita**. Saem o código verificador, o CRMV e a validade.
22. Mostre o bloco **"Como o responsável vê"**: a mesma prescrição em linguagem de quem vai dar o remédio.
23. Clique em **"Enviar ao responsável"**. Fica registrado com data e hora.
24. Se houver receita anterior, mostre **"Repetir"** — traz tudo de uma vez.

> *"É aqui que o elo aparece. A mesma prescrição que o veterinário escreveu chega no aplicativo de quem levou o animal, já em linguagem de casa, sem ninguém digitar duas vezes. E vira lembrete no horário certo."*

Por que isso vende: É o diferencial que os concorrentes não têm. Guarde-o para o fim do ato do atendimento, quando a plateia já entendeu o resto.

Ato 6 · Vacinas — a consulta que a clínica provoca

`/veterinario/vacinas` **1 min 30 s**

Este é o ato comercial da apresentação. Se o tempo apertar, corte outro — não corte este.

25. Abra **Vacinas**. Mostre as três pilhas: **vencido**, **a vencer** e **série aberta**.
26. Aponte o número de **"Agenda a recuperar"** no topo.
27. Escolha uma linha e mostre os botões **Ligar** e **Agendar**, ali mesmo.

> *"Esta tela não espera o cliente ligar. Ela diz quem está com reforço vencido, quem vence nos próximos trinta dias, e quem começou uma série de vacina e não voltou para a segunda dose. Cada linha aqui é um atendimento que a clínica já ganhou e não cobrou."*

Por que isso vende: É a única tela que fala em faturamento, e é a que fica na cabeça do dono da clínica depois que a reunião acaba.

Ato 7 · Os documentos e o fechamento

`etapa "Resumo" do atendimento` **1 min**

28. Volte ao atendimento, etapa **Resumo**.
29. Mostre os **documentos sugeridos** — três ou quatro cartões, montados a partir do que **este** atendimento tem.
30. Abra **"Outros documentos"** e passe os olhos pela lista: termos, declarações, encaminhamento, orçamento.

> *"São quinze documentos possíveis, mas a tela só oferece os três ou quatro que esta consulta pede. O resto está a um clique, sem entulhar a tela de quem está com o animal na mesa."*

Feche olhando para a pessoa, não para a tela:

> *“O que vocês viram é um dia de trabalho: a recepção sabendo onde está, a falta virando ligação, a consulta registrada sem papel, a receita chegando no celular do responsável e a clínica sabendo quem chamar de volta. Queria entender qual desses cinco resolveria mais problema para vocês.”*

Por que isso vende: Termine com pergunta, não com resumo. A resposta dela é o que define a proposta.

Perguntas que o cliente vai fazer

As sete mais comuns, com a resposta curta. Responder com segurança vale mais que qualquer tela.

Pergunta	Resposta
“Isso já funciona ou é maquete?”	As telas funcionam de verdade. O que ainda não existe é a integração com servidor — hoje roda com dados de demonstração. É protótipo navegável, e a fase é de validar com clínicas antes de construir o motor.
“Meus dados ficam onde?”	A pergunta é legítima e a resposta honesta é: a arquitetura está definida, a implementação não. Anote e leve para a equipe técnica — não improvise.
“Funciona no celular?”	O portal é responsivo, mas a agenda e o prontuário foram desenhados para tela grande, que é onde se atende. O celular é o lado do responsável, não o da clínica.
“Quantos veterinários suporta?”	A agenda é multiprofissional e multissala. Na demonstração há cinco veterinários e várias salas ao mesmo tempo.
“Importa meus dados do sistema atual?”	Ainda não está construído. Não prometa prazo — anote qual sistema eles usam hoje, que é a informação que a equipe precisa.
“E o preço?”	Fora do escopo desta apresentação. Encaminhe para a conversa comercial.
“Quando fica pronto?”	Não dê data. Diga que a fase atual é ouvir clínicas, e que a opinião deles entra no que será construído primeiro — o que é verdade e é o melhor convite possível.

O que é real e o que é demonstração

Esta seção existe para proteger quem apresenta. Prometer o que não existe custa a próxima reunião.

Funciona de verdade nas telas

- Agenda multiprofissional e multissala, com encaixe, bloqueio e arraste com confirmação
- Detecção de conflito: sobreposição, sala ocupada, invasão de bloqueio, fora do expediente
- Prontuário completo, com salvamento automático e aviso quando dois aparelhos abrem o mesmo
- Faixas de referência por espécie, **porte e idade**
- Cálculo de dose com a conta aberta, fracionamento e aviso de alergia por princípio ativo
- Registro de vacina com lote, fabricante, validade e dose da série
- Lista de chamada de reforço: vencido, a vencer e série aberta
- Quinze documentos em folha A4, com impressão pelo navegador
- Fila de espera com posição, oferta e prazo
- Digitação da consulta inteira pelo teclado

A forma está certa, o motor ainda não existe

O que a tela mostra	O que ainda não acontece
Assinatura eletrônica com código verificador	O código é gerado localmente; virará assinatura criptográfica de verdade
“Enviar ao responsável”	O envio fica registrado, mas quem entrega é o aplicativo — outro projeto, ainda não conectado
Lembrete de medicação	Nasce da posologia e é exibido; quem dispara no celular é o aplicativo
Aviso de remarcação e oferta de vaga	O texto é gravado como comprovante; nenhuma mensagem sai
Pré-consulta respondida no aplicativo	O dado está plantado na demonstração; a coleta é do aplicativo

Não existe — não prometa

- **Nenhuma integração com servidor.** Tudo roda com dados de demonstração no próprio navegador
- **Preços**: o orçamento sai com os itens listados e os valores em branco
- **Plano de saúde do paciente**: operadora e apólice são preenchidos à mão
- **Microchip**
- **Importação de dados** de outro sistema

> Se o cliente pedir algo desta última lista, a melhor resposta é anotar na frente dele e dizer que vai para a lista do que construir primeiro. Isso vale mais que uma promessa vaga — e é o que esta fase do produto realmente precisa ouvir.

Plano B

O que fazer quando algo não responde, sem quebrar o ritmo da apresentação.

Se acontecer	O que fazer
O menu “Clínico” não aparece	O módulo está desligado. Acrescente ?clinico=on ao endereço e recarregue. Se persistir, digite “clinico” com a tela aberta, fora de um campo de texto.
A agenda abre vazia	Verifique se é domingo. Se for, o ato 1 e o ato 2 não têm dado — pule direto para o prontuário, que funciona em qualquer dia.
Uma tela demora ou trava	Recarregue a página (F5). Os dados são recriados na hora e nada se perde, porque nada está salvo em servidor.
Errou um passo e a tela ficou em estado estranho	Recarregue. É a vantagem de rodar sobre dados de demonstração: o mundo volta ao início.
O projetor corta as colunas da agenda	Use o painel de exibição para reduzir a dois profissionais, ou diminua o zoom do navegador para 80 %.
Perguntaram algo que você não sabe	Anote na frente da pessoa e diga que traz a resposta. Numa fase de protótipo, isso constrói mais confiança que responder por cima.

Uma última coisa

A apresentação não precisa terminar com o cliente convencido. Ela precisa terminar com ele **falando do dia dele** — quantas faltas tem por semana, quantas vacinas deixa de cobrar, quanto tempo o veterinário gasta escrevendo. É essa conversa que decide a próxima reunião, e o roteiro inteiro existe para chegar até ela.